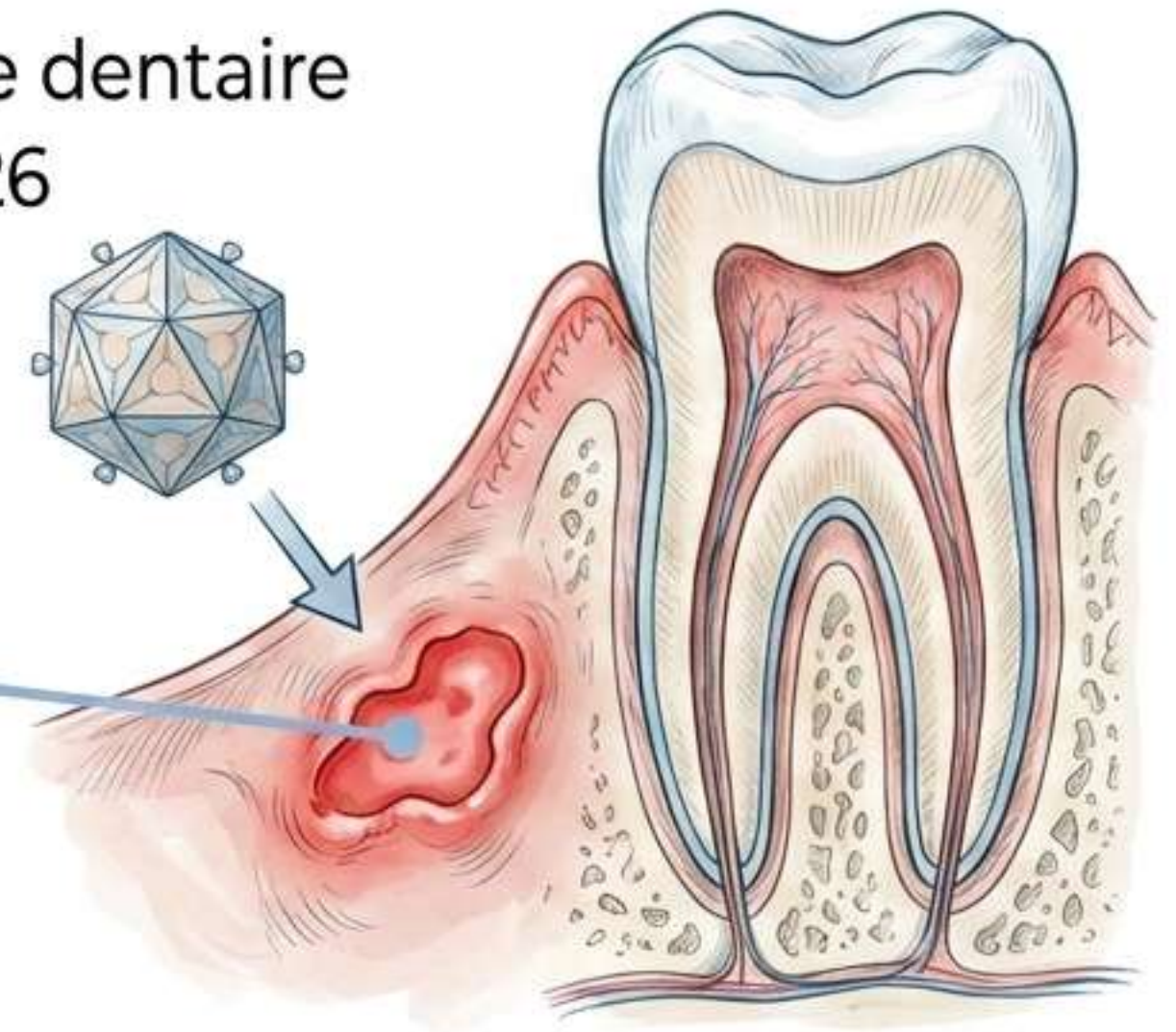


# Physiopathologie des Infections Virales

Dr Aicha BENSALEM

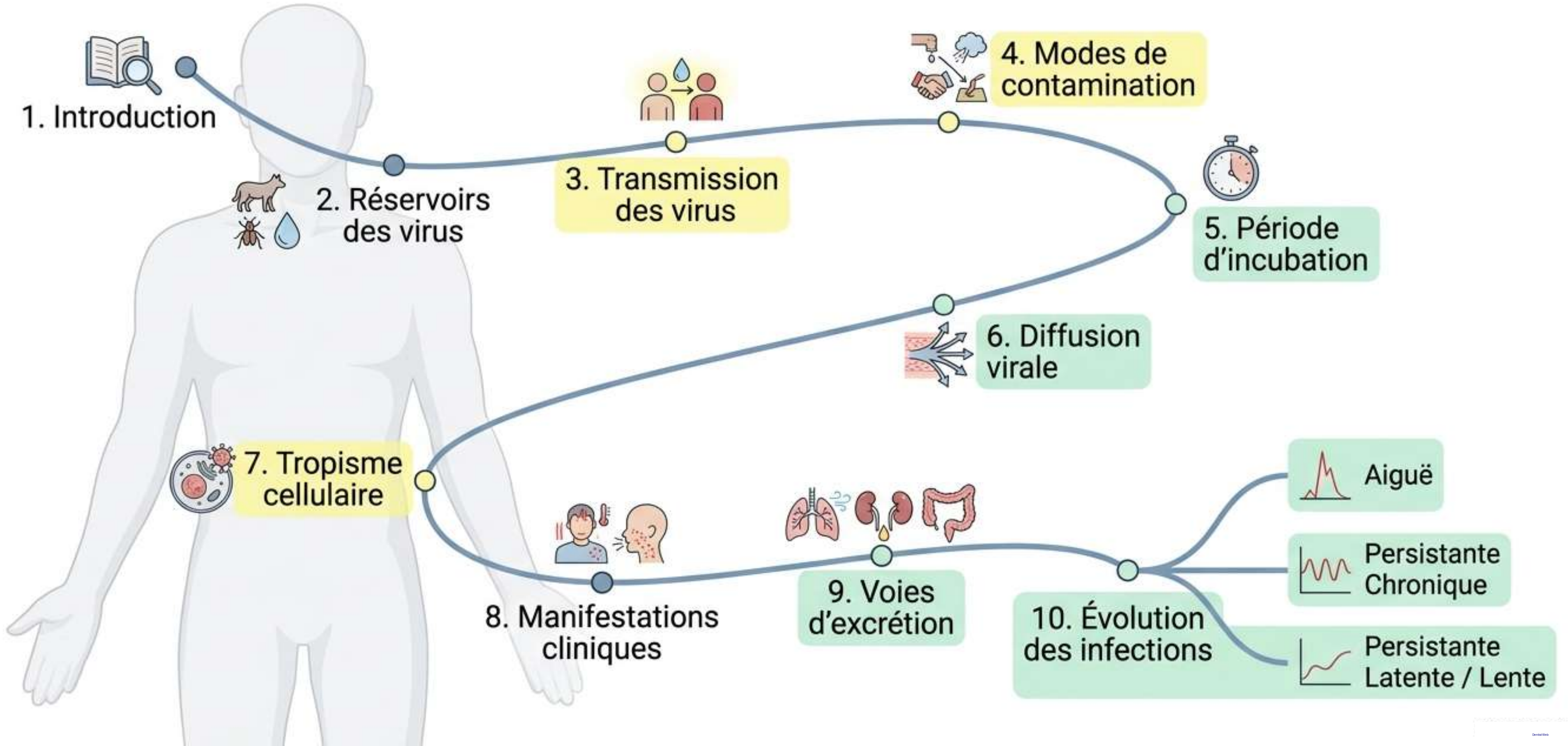
Cours graduation 2è année Médecine dentaire  
Année universitaire 2025-2026

**Objectif Principal :** Comprendre comment les virus peuvent produire des lésions dans la cavité buccale.





# Plan du Cours : Le Voyage Viral





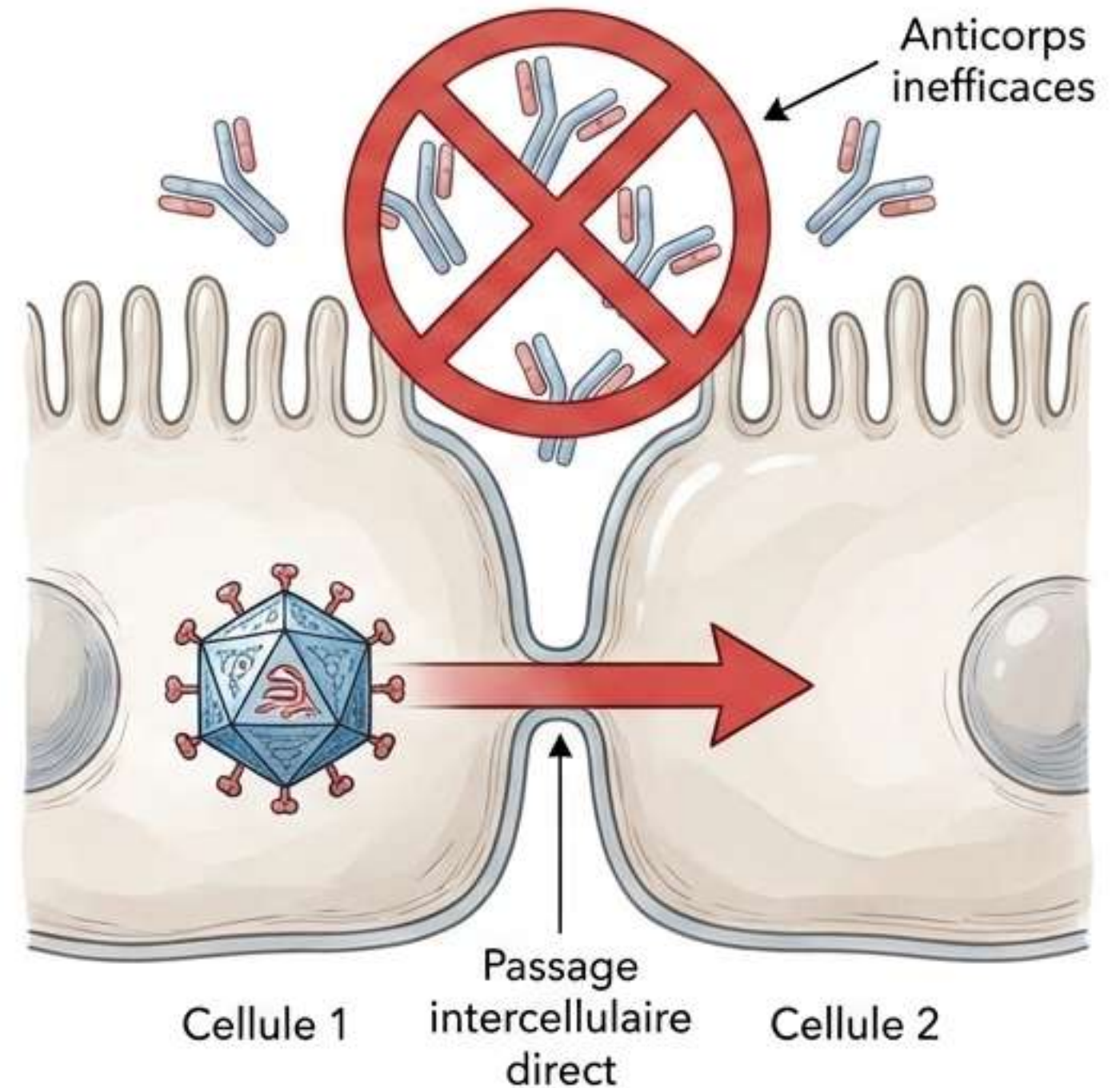
# Généralités : Parasitisme et Évasion

## Définition stricte :

Un virus est un **parasite intracellulaire obligatoire** qui détourne à son profit les fonctions fondamentales de la cellule qu'il infecte.

Un virus peut passer de cellule en cellule sans sortir dans le milieu extracellulaire. Il peut-être à l'abri de l'immunité humorale (anticorps) extra cellulaire.

*[Predicted - Concept fondamental sur les mécanismes d'échappement immunitaire]*





# Initiation de l'Infection et Cascade d'Invasion

**Entrée dans la cavité buccale** suivie de **destructions tissulaires** (ulcérations, vésicules).

## Infection locale

Le virus se multiplie exclusivement au niveau du site d'entrée (Exemple : Herpesviridae).

## Infection systémique

Le virus se multiplie dans des tissus distants de la porte d'entrée impactant la santé buccale (Exemples : virus des hépatites, VIH).

### 1- Invasion de l'organisme par un virus

Pénétration

Diffusion

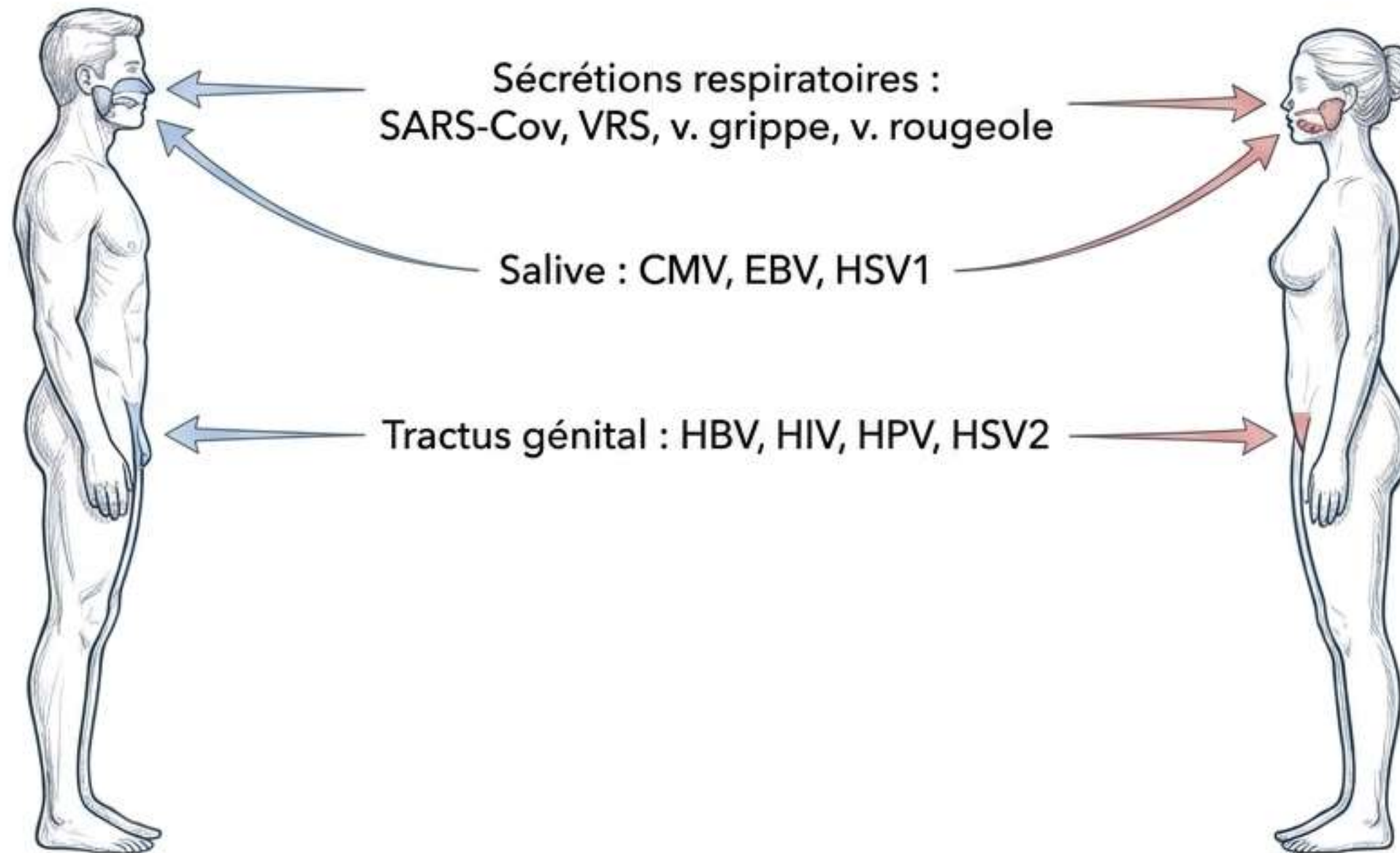
Tropisme cellulaire

Infection virale

# Réservoirs des Virus Pathogènes : Focus Humain

## L'Homme : principal réservoir.

*[Ref: Q8 - Piège d'examen : L'animal n'est pas le réservoir principal pour ces virus humains].*

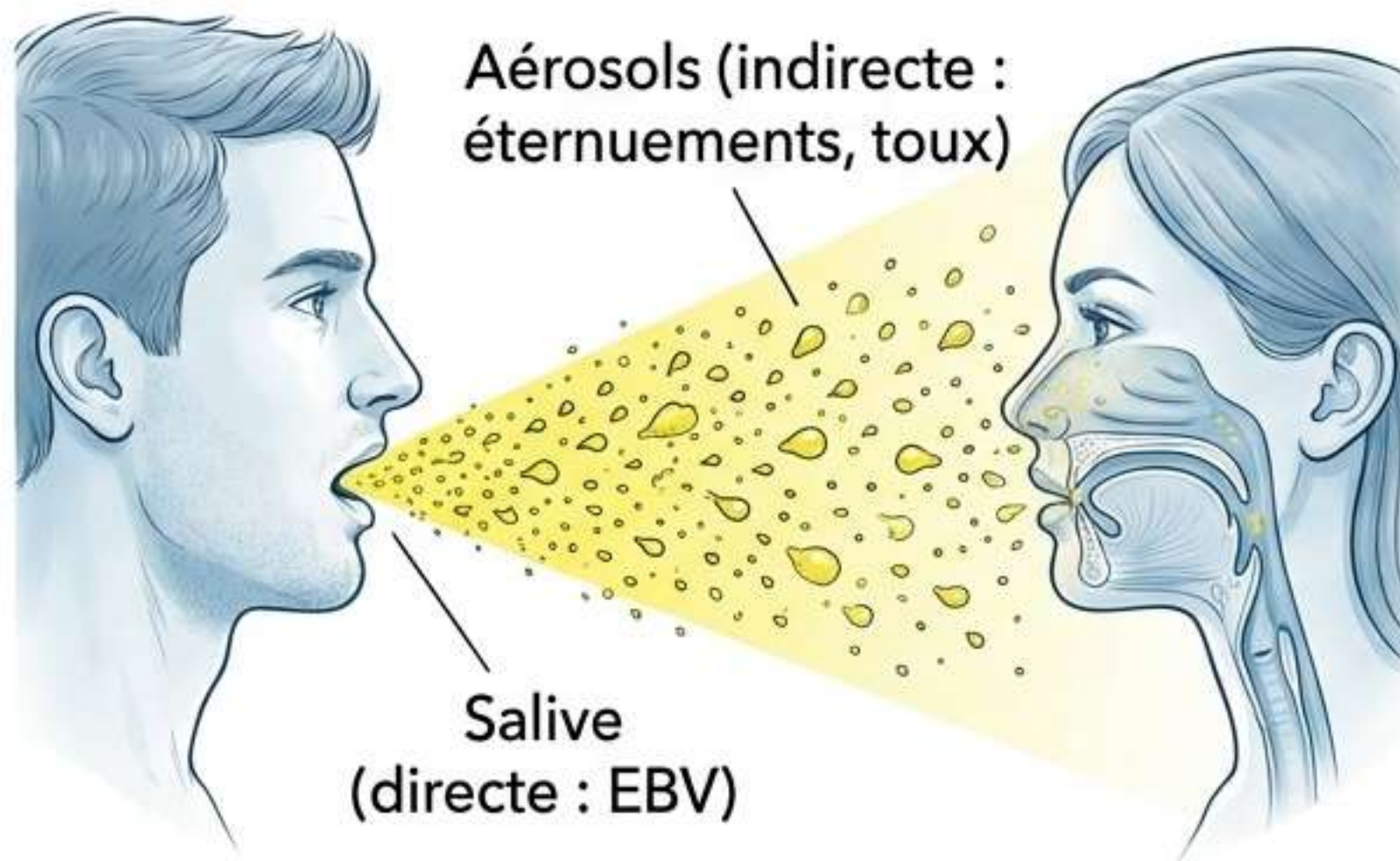




# La Transmission et Modes de Contamination

**Transmission :** À travers une porte d'entrée par contact direct avec les muqueuses et la peau par les fluides biologiques (Salive, Contenu vésiculaire, Sécrétions génitales). [Ref: Q1]

## Contamination Aérienne

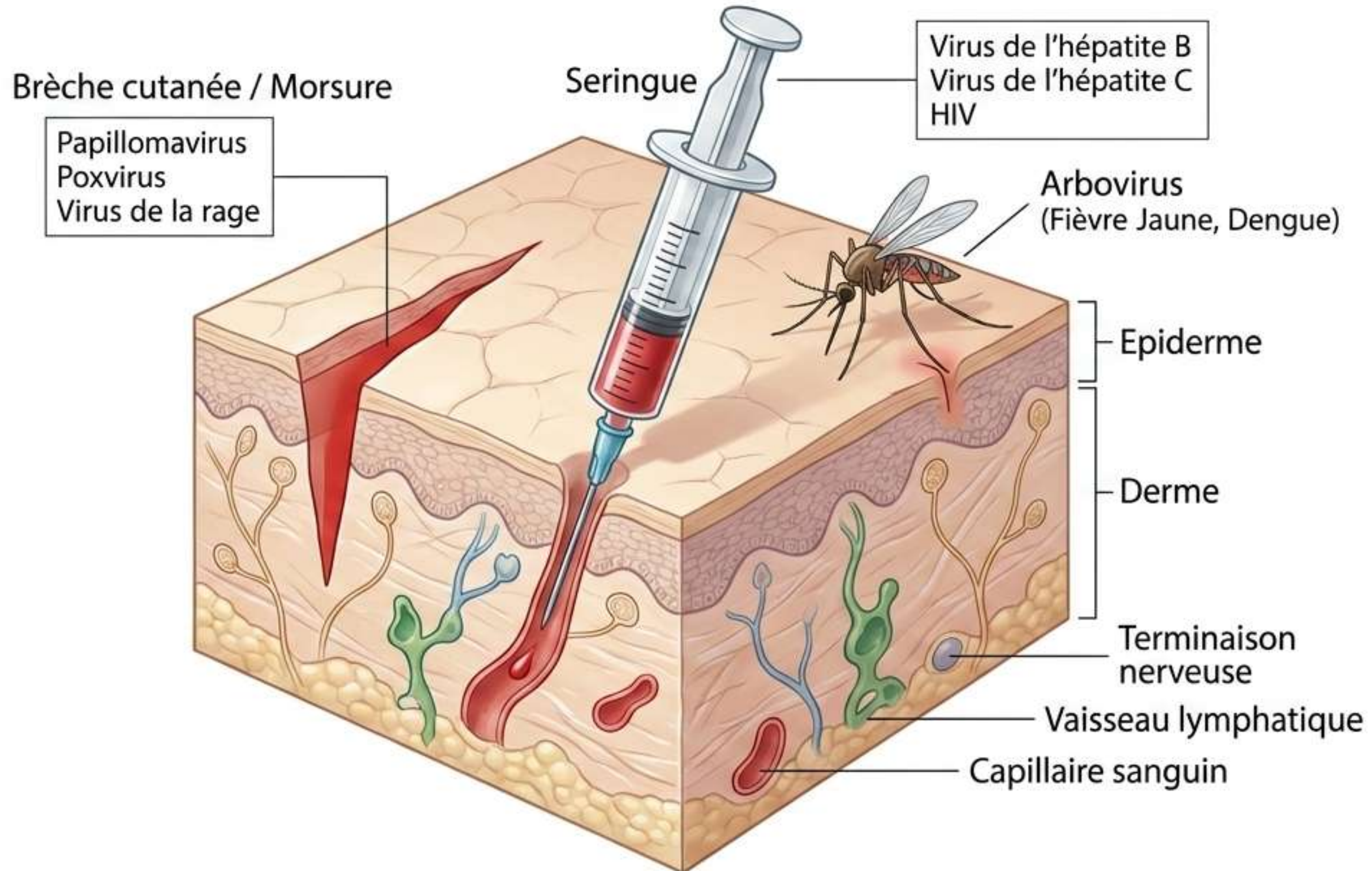


## Autres Modes





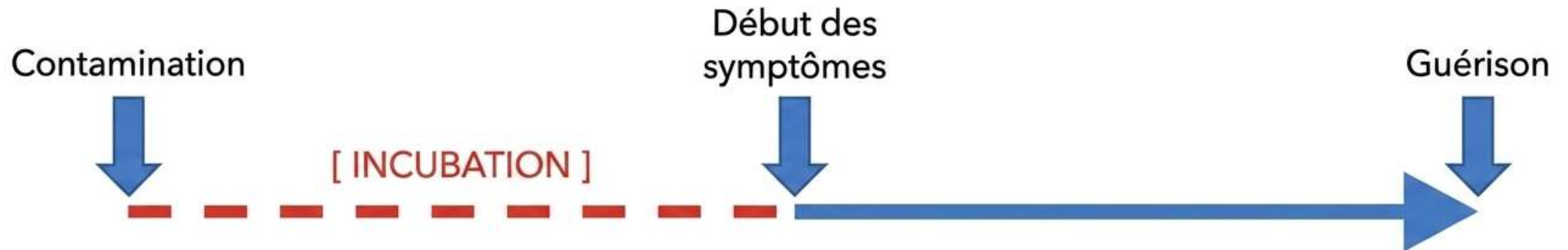
# Modes de Transmission : Portes d'Entrée Transcutanées





# Cinétique : La Période d'Incubation

Période silencieuse allant du contagé à l'apparition des premiers signes cliniques.



Site de multiplication = Porte d'entrée (Infection locale) -> Période d'incubation COURTE. [Ref: Q3]  
Exp: Grippe.

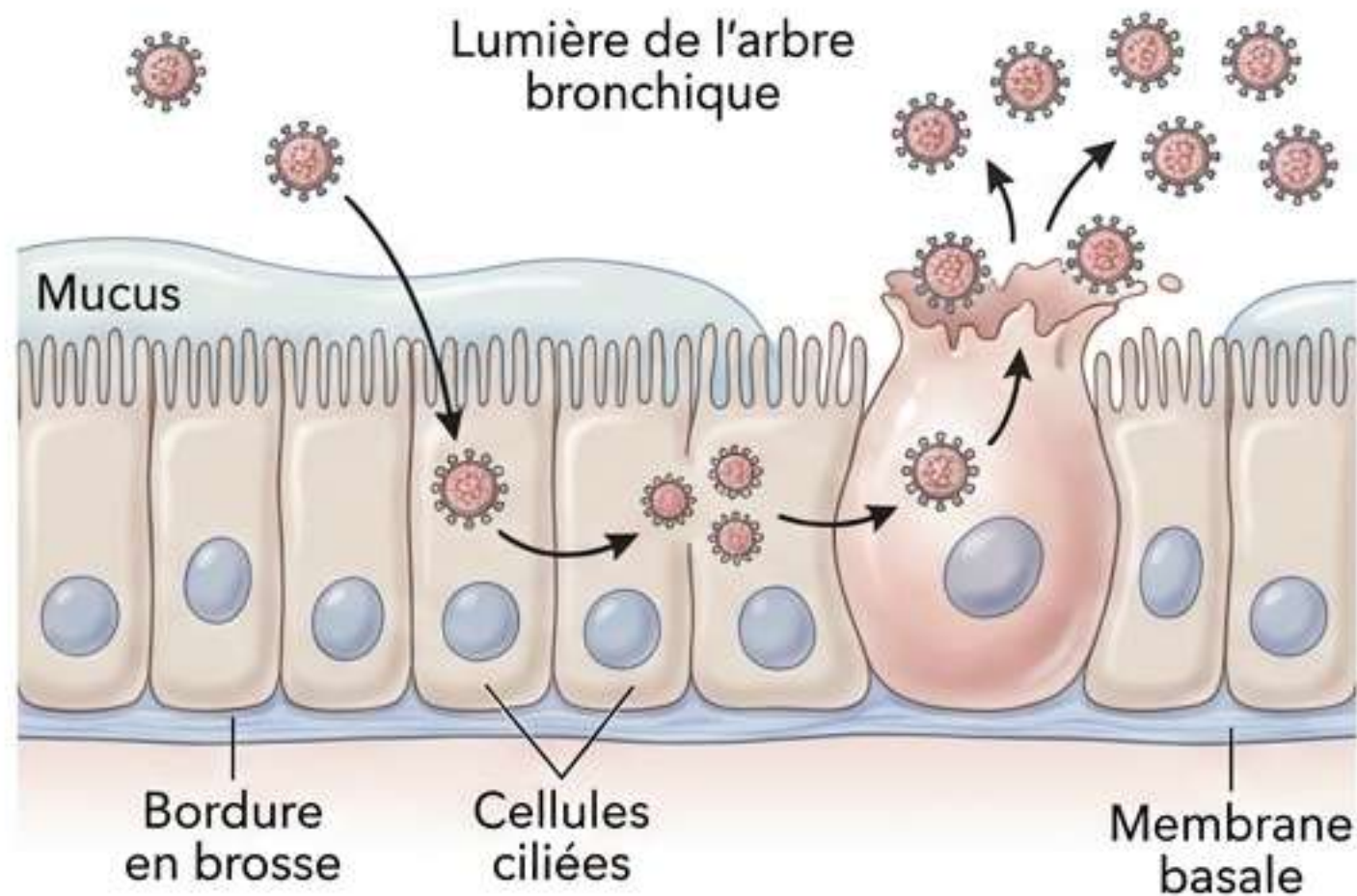
Site de multiplication distinct de la porte d'entrée (Infection générale) -> Période d'incubation LONGUE (semaines/mois). [Ref: Q3]  
Exp: Hépatites, VIH.



# Diffusion Virale : Locale vs Systémique

## Diffusion Locale

Multiplication locale puis rejet direct dans le milieu extérieur (Exp: respiratoire - rhinovirus, influenzaeavirus).

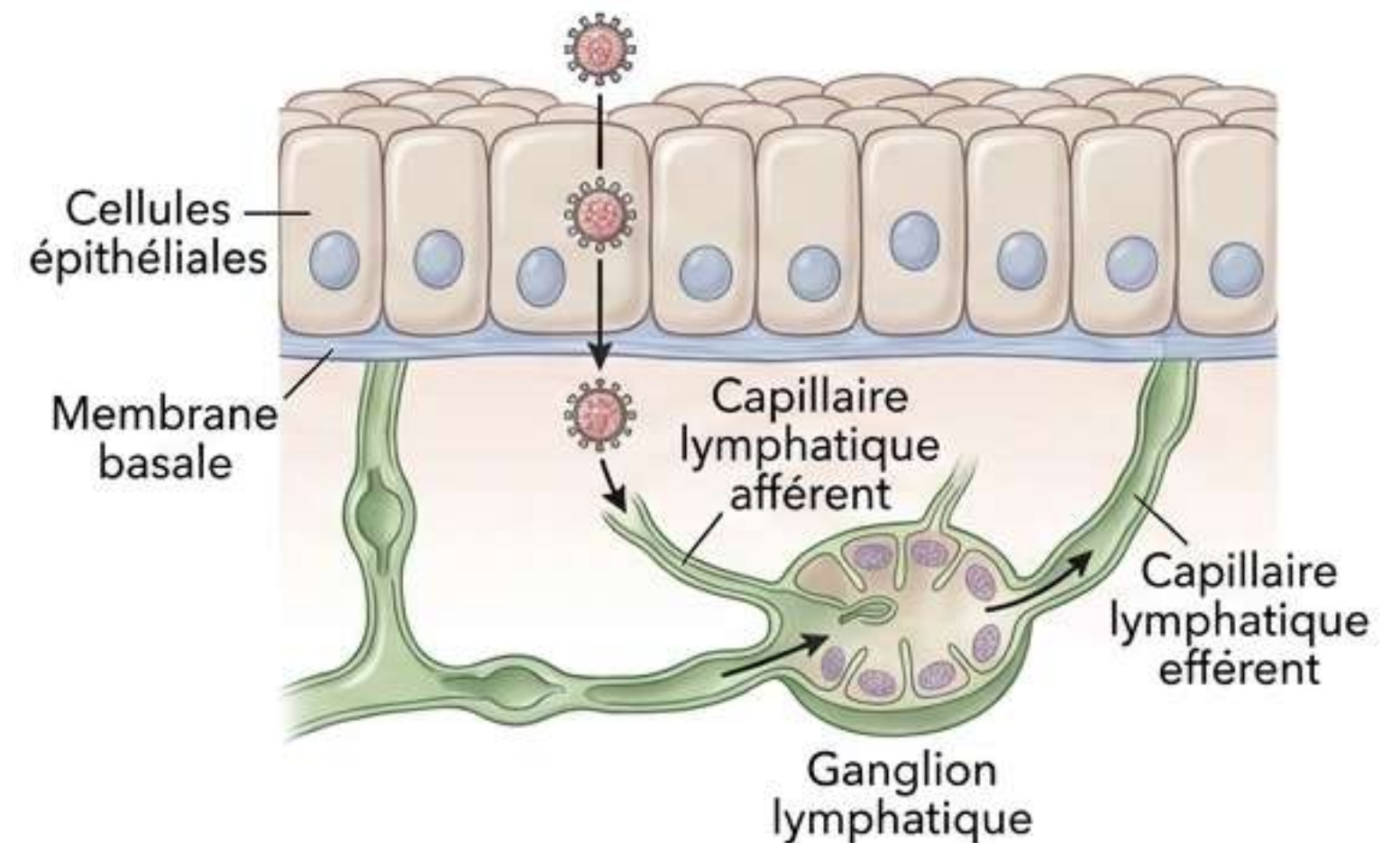


## Diffusion Systémique

Sanguine et lymphatique. Véhicule le virus vers les organes cibles.

Transport libre dans le plasma : HBV, HCV, HIV. [Ref: Q6]

Transport associé aux cellules : CMV, EBV, HIV.



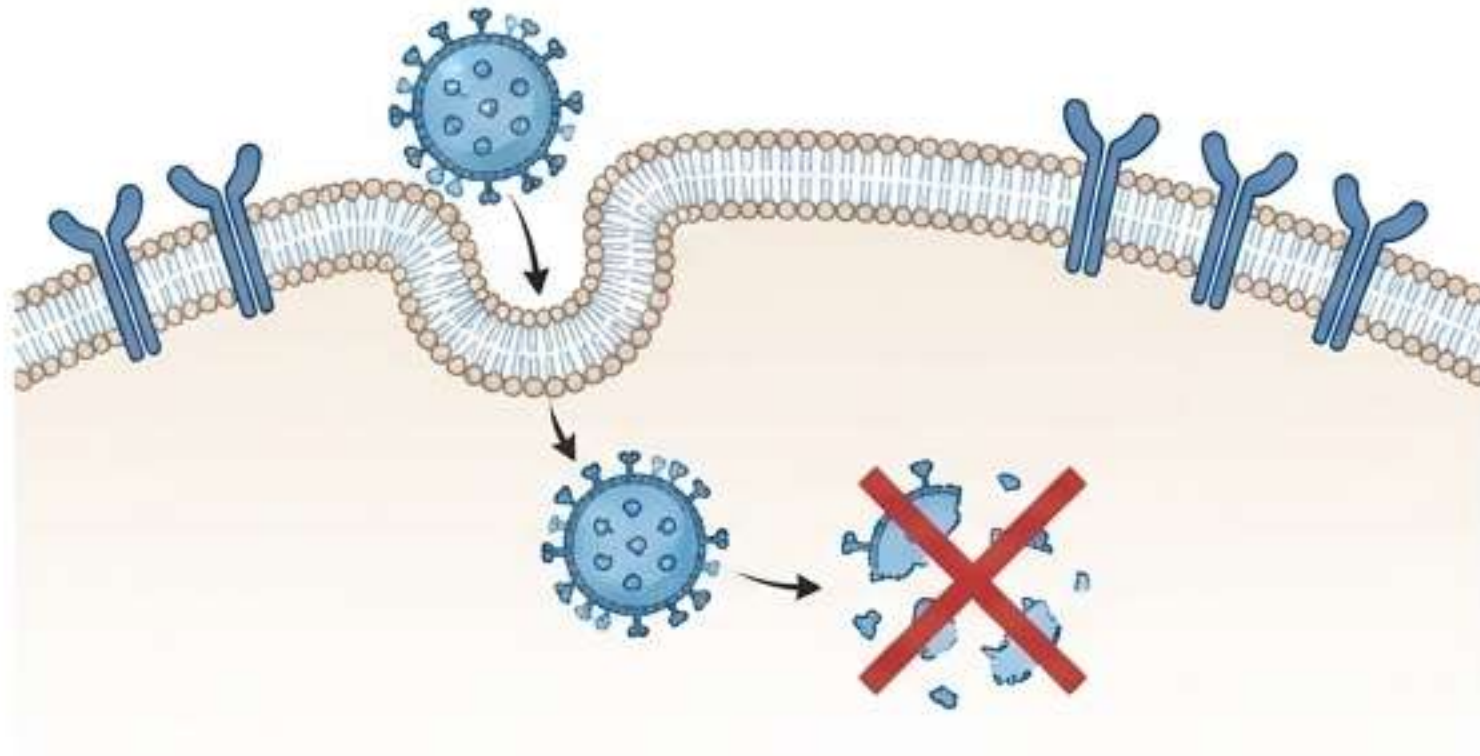


# L'Organe Cible : Déterminants du Tropisme Cellulaire

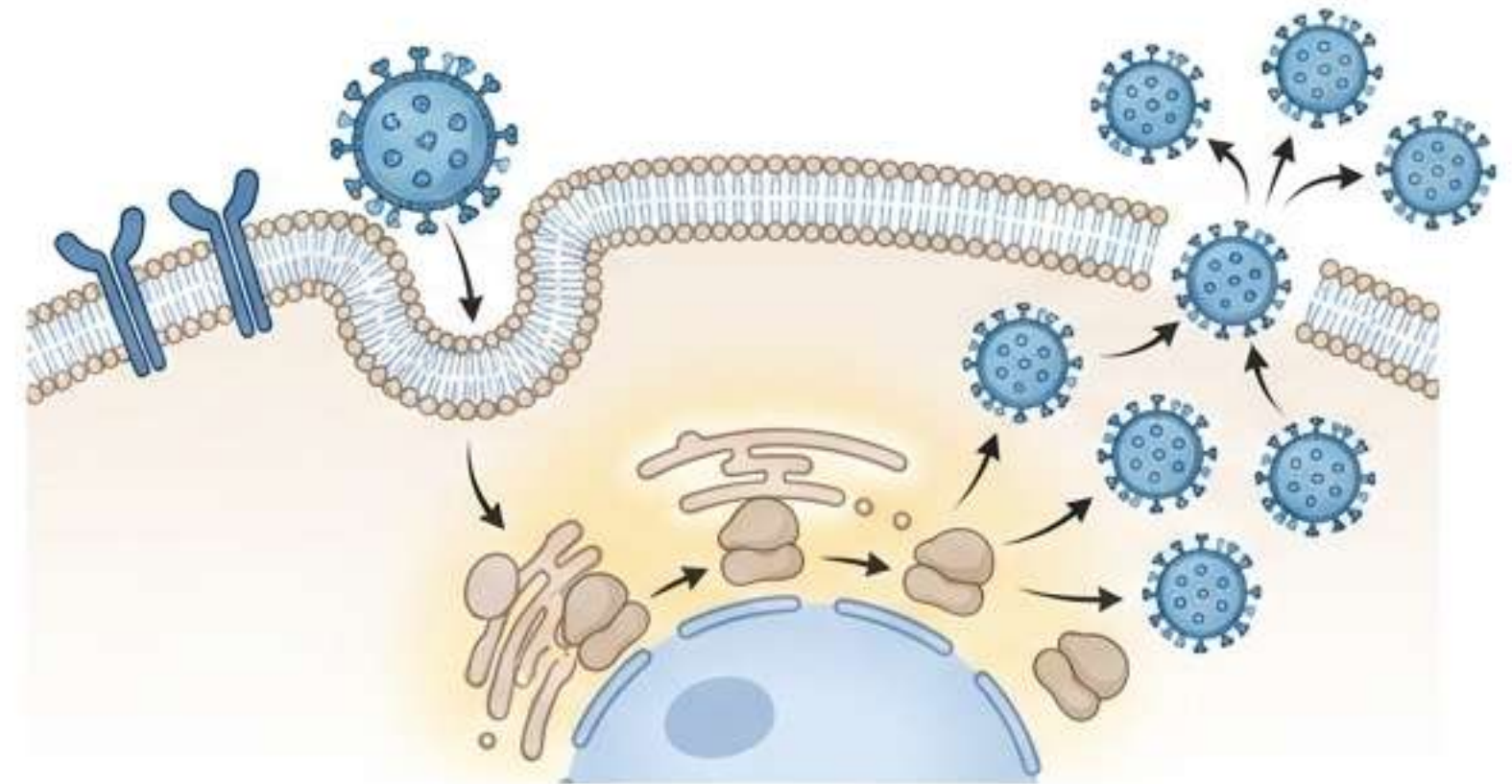


**Axiome d'examen :** Une cellule sensible n'est pas obligatoirement permissive.  
(Corollaire : Une cellule permissive est obligatoirement sensible). [Ref: Q4]

Cellule Sensible MAIS NON Permissive

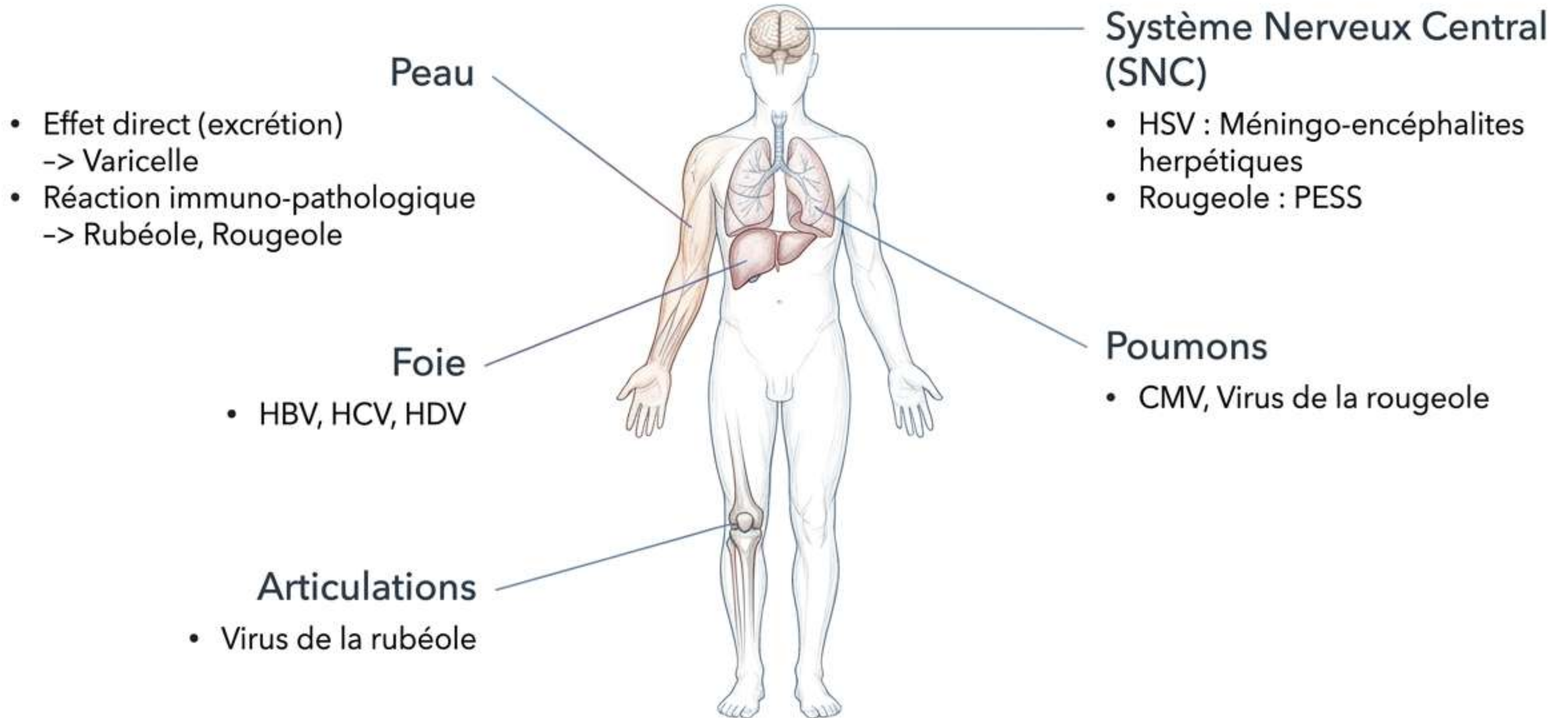


Cellule Sensible ET Permissive





# Manifestations Cliniques par Organe



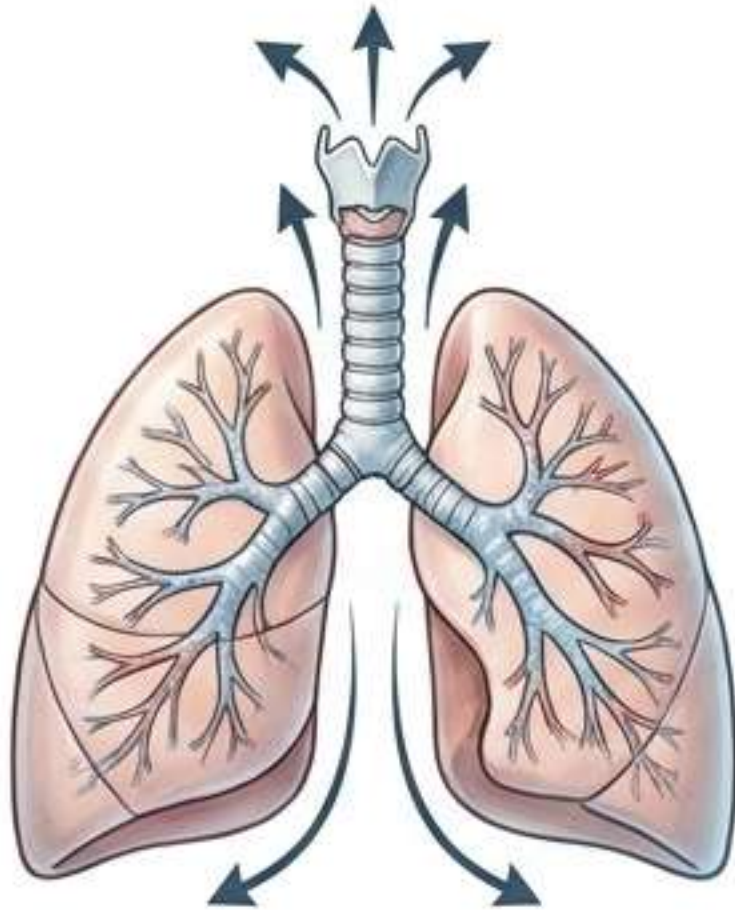


# Voies d'Excrétion Virale

Plusieurs voies d'excrétion existent pour permettre la dissémination dans l'environnement et la contamination d'un nouvel hôte.

**Voies formellement documentées dans le cours.**

[Ref: Q2 - Attention au piège de l'examen sur les fausses voies d'excrétion]



## Respiratoire

Grippe, oreillon, rougeole, rubéole



## Salive

CMV, EBV



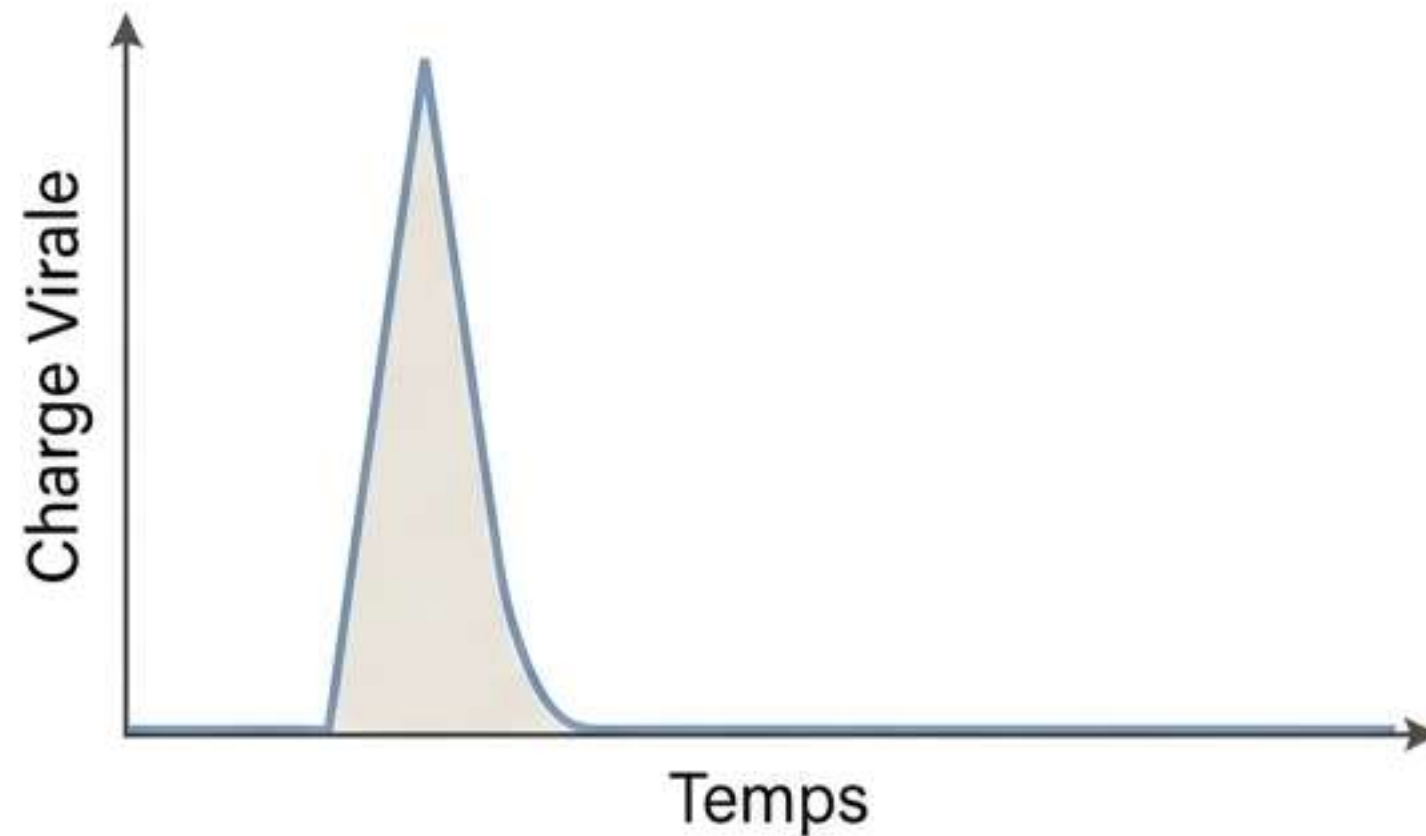
## PIÈGE D'EXAMEN

Les virus ne sont PAS excrétés par la sueur.



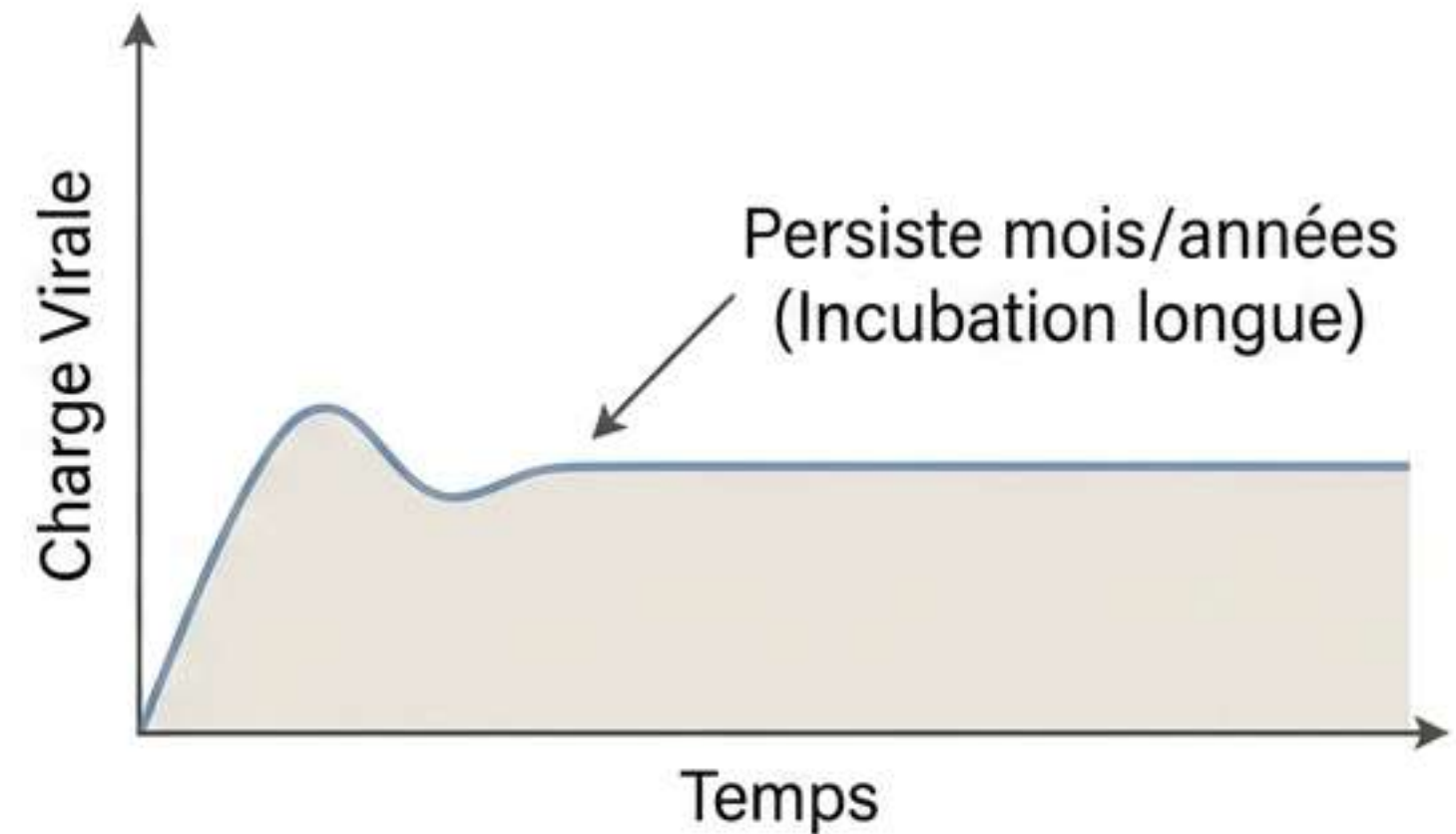
# Évolution des Infections Virales : Aiguë vs Persistante

## Infection Aiguë



- Souvent asymptomatique.
- Multiplication limitée dans le temps, intense et rapide.
- Excrétion rapide suivie d'une réponse immunitaire (anticorps protecteurs).

## Infection Persistante Chronique

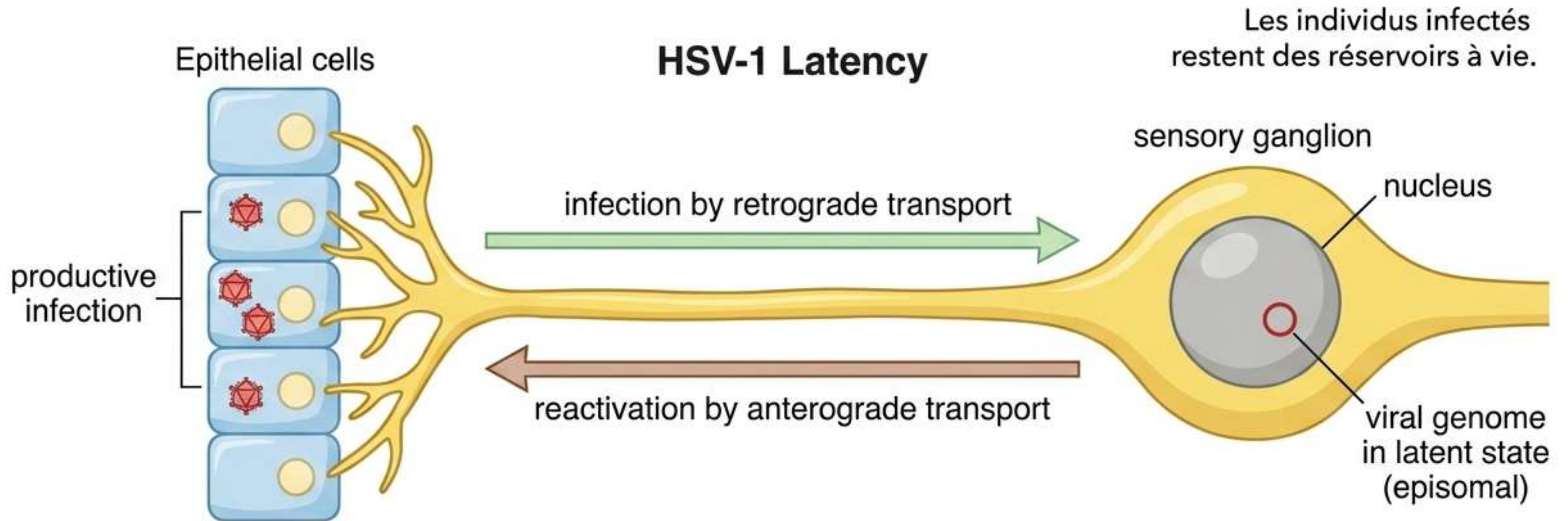


- Fait suite à une infection aiguë.
- Présence continue du virus dans l'organisme (sang, tissus, organes).
- Exemples : HBV, HCV.



# Évolution : Infection Latente ou Récurrente

Épisodes aigus séparés par des phases de dormance. Durant la dormance, le virus n'est PAS retrouvé sous forme particulière. [Ref: Q7] Exemples : HSV, VZV.



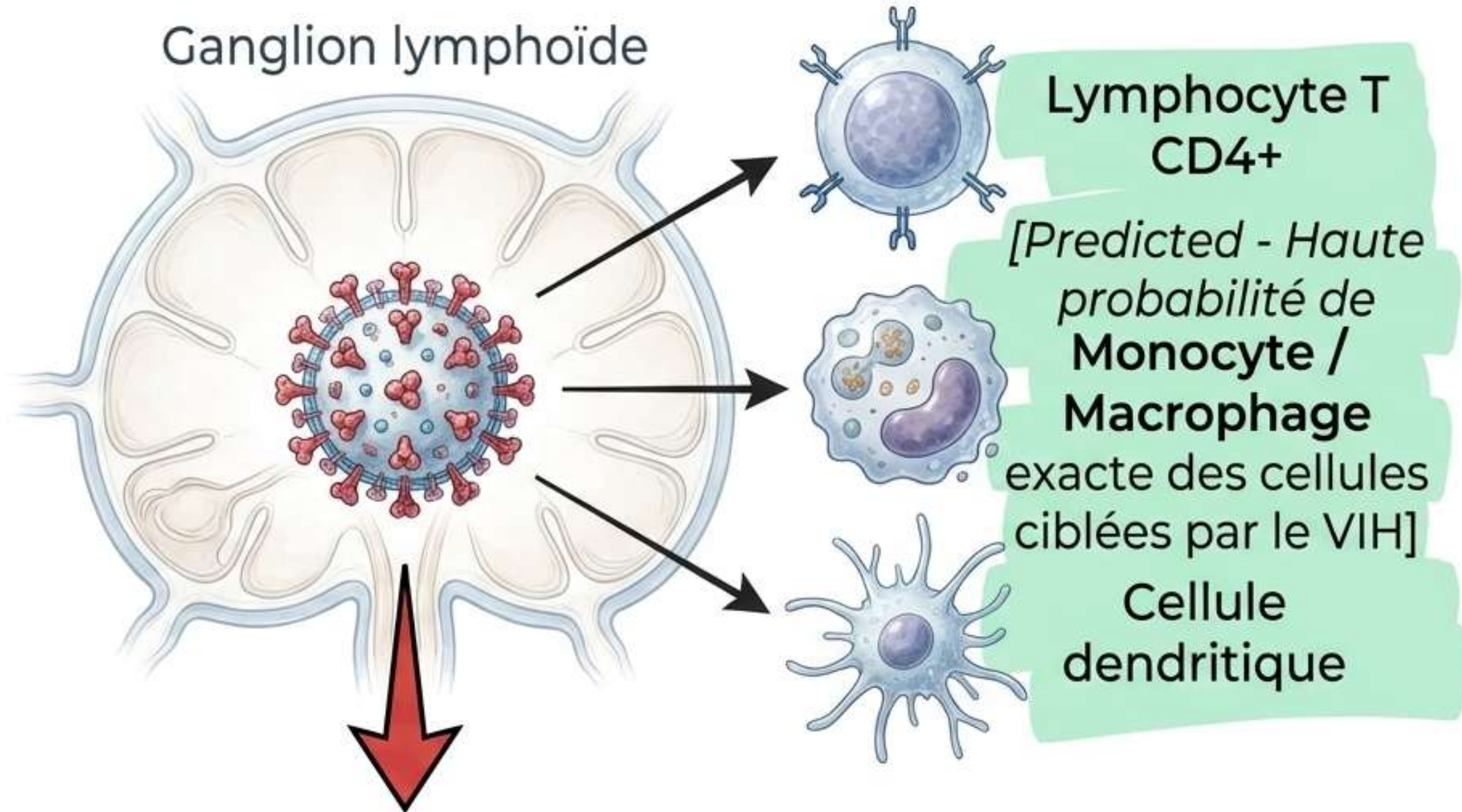


# Évolution : Infection Lente et Déficits Immunitaires

## Infection Lente :

Incubation très longue.  
Multiplication virale très lente avec parasitisme progressif. Évolution insidieuse et fatale.

**Exp :** VIH/sida, virus rougeoleux (PESS).



**Destruction de TOUT le système immunitaire  
(Déficit majeur définitif)**

(Déficits modérés et transitoires : exp. virus de la rougeole)



# Exam Pattern Analysis : Stratégie de Révision

## Highest Yield (Concepts Répétés)



- Incubation locale vs systémique (Corrélation Porte d'entrée = Site multiplication).
- Dynamique de la Latence (Disparition de la forme particulière HSV/VZV).
- Sensibilité n'équivaut pas à Permissivité.

## Le Piège Absolu (The Trap)



**Le Réservoir de la Grippe**  
**Le Réservoir de la Grippe**  
Bien que l'actualité cite les oiseaux/porcs, le cours désigne formellement l'Homme comme réservoir principal.  
Cochez selon le PDF !

## Prédictions Futures



- Mécanisme de transmission cellule à cellule (échappement immunitaire).
- La triade cellulaire ciblée par le VIH (Lym T CD4+, Macrophages, Dendritiques).



# Mind Map Final : Physiopathologie des Infections Virales

